جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هاجر محمد سعيد صابر

المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** بلبيس **العنوان :** ش القاضي مركز بلبيس

رقم البطاقة : 30001021300129 **رقم التليفون :** 01212565552 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 02-01-2000 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : اورام ليمفاويه
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : اورام ليمفاويه
خطة العلاج : أورام كيماوي زولاديكس تحت الجلد لمده 6 شهور [14163] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هاجر محمد سعيد صابر
National ID: 30001021300129

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of lymphoma for Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


٣٠٠٠١٠٢١٣٠٠١٢٩ ٢٠٢٥/٠٣
حاصله على دبلوم صنايع
أنثى مسلمة البلة
٨ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٣/١٢


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
هاجر
محمد سعيد صابر عبدالفتاح
ش القاضى
مركز بلبيس - الشرقية
٣٠٠٠١٠٢١٣٠٠١٢٩
LB3594229

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : هاجر محمد سعيد صابر
Analysis ID : 1040390
Age : 26 Y : 2 M : 8 D Gender : Female Conf. Code : 1591
Referred By Prof. Dr. : محمود حسان
Clinical Diagnosis : Enlarged right axillary lymph node, and subpectoral lymph node.
Nature of Specimen : Biopsy.
Receiving Date : 2026-03-10 Patient ID : 763655

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Two nodules, largest measured 4x2.5x2 cm and smallest measured 4x3x2 cm. Both with rubbery tan cut sections.

Microscopic :

Sections examined from the specimen received revealed large lymph nodes showing effaced architecture with nodular pattern formed mostly of small cells and scattered large cells, some are binucleated and multinucleated.

Diagnosis :

Right axillary and subpectoral lymph node, Biopsy, MALIGNANT LYMPHOMA, COMPATIBLE WITH NON CLASSIC NODULAR LYMPHOCYTIC RICH HODGKIN'S LYMPHOMA, PATTERN A.
- IMMUNOPHENOTYPING IN SEPARATE REPORT.

Prof. Dr. Shady Elia Anis *Prof. Dr. Elia Anis Ishak*

This report is electronically signed , any abrasion or modification would

DR ELIA ANIS LABS
عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١٢١٢٩٤٥١١٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧

Name: هاجر محمد سعيد صابر **MR. :** 10210	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Recurrent non-classic nodular non-Hodgkin lymphoma; bone marrow aspiration and biopsy showed high normocellular marrow for age with no reactive background or abnormal infiltration.

Patient is single, Stage 2a PHD. Referred for ABVD x 4 then reevaluate if CR; if not, consider Zoladex.

For ABVD C 3 D 1 labs accepted for premedications with Avil, Dexa, Zofran. The patient has completed 2 full cycles of ABVD and has begun cycle 3.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : شريف الشناوى

يعتمد ,

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : هاجر محمد سعيد صابر
Analysis ID : 1040391
Age : 26 Y : 2 M : 8 D Gender : Female Conf. Code : 5865
Referred By Prof. Dr. : محمود حسان
Clinical Diagnosis : Enlarged right axillary lymph node and subpectoral lymph node.
Nature of Specimen : Block (1040390, Biopsy)
Receiving Date : 2026-03-10 Patient ID : 763655

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Technique :

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain .
The sections were treated against:
CD 20 \ CD 3 \ Ki67 \ OCT 2 \ CD 30 \ CD 21 \ CD 79a

Results :

Large and small neoplastic lymphoid cells are POSITIVE for CD20 in nodular pattern.
The neoplastic lymphoid cells are NEGATIVE for CD3 and positive in reactive T lymphocytes, some forming rosettes around large cells.
20% of neoplastic lymphoid cells are POSITIVE for KI67.
Large neoplastic lymphoid cells are POSITIVE for OCT2.
The neoplastic lymphoid cells are FEW POSITIVE for CD30.
CD21 showed positive dentritic meshwork
Large neoplastic lymphoid cells are POSITIVE for CD 79a.

Conclusion :

Block, FINDINGS ARE COMPATIBLE WITH NON CLASSIC NODULAR LYMPHOCYTIC *RICH HODGKIN'S LYMPHOMA*, PATTERN A.

Prof. Dr. Shady Elia Anis *Prof. Dr. Elia Anis Ishak*

This report is electronically signed , any abrasion or modification would ren

DR ELIA ANIS LABS

عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١٢١٢٩٤٥١١٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧

أ.د. خالد أحمد لكوظ
أ.د. أحمد صبري راغب أ.د. أيمن فتحي أحمد
أ.د. ماجد عبدالجليل د. تامر محمد إبراهيم
د. كريم خالد لكوظ د. محمد هشام صالح

Patient Name: هاجر محمد سعيد صابر	Study Date: 08/12/2025
PROF: عبداللطيف معوض	Patient ID: 756008

18F-FDG PET-CT EXAMINATION

HAGAR MOHAMED SAID SABER



History: -

A 25 years old female patient presented with history of enlarged suspicious right axillary lymph nodes, pathologically proven to be atypical lymphoid infiltrate, referred for further PET/CT assessment.

Procedure:-

- 7.2 mCi 18F-FDG was administrated to the patient and imaged after appropriate time.
- The blood glucose level was 76 mg/dl.
- A low dose non-contrast CT for attenuation correction and anatomic localization followed by PET images from the skull vault to the mid-thigh were obtained.
- A diagnostic 128 MDCT non-contrast examination was taken of the same regions. Images of CT and corresponding functional PET images are taken in axial, coronal and sagittal planes.

PET/CT FINDINGS: -

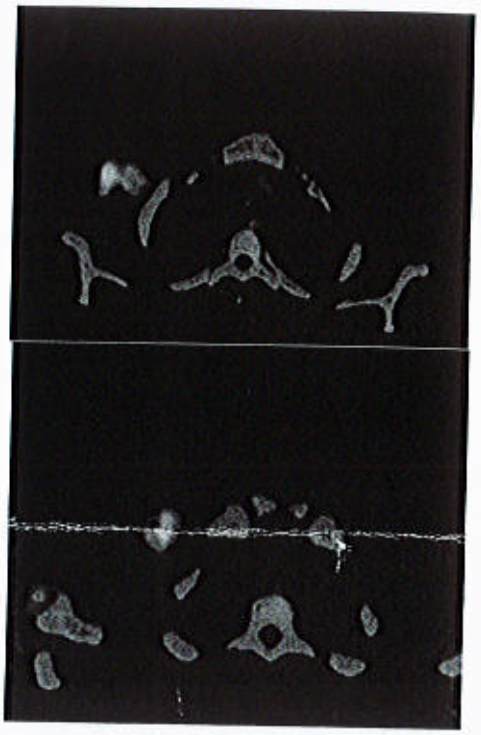
A] Head and Neck:-

- **Insignificantly avid right upper deep cervical lymph nodes measuring up to 10 mm and achieving up to 3 SUV max, could be reactive in nature.**
- The visualized portions of the brain exhibited normal FDG biodistribution.
- Physiological FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands and larynx.
- No parenchymal thyroid focal lesions could be elicited.

Patient Name: هاجر محمد سعيد صابر	Study Date: 08/12/2025
PROF: عبداللطيف معوض	Patient ID: 756008

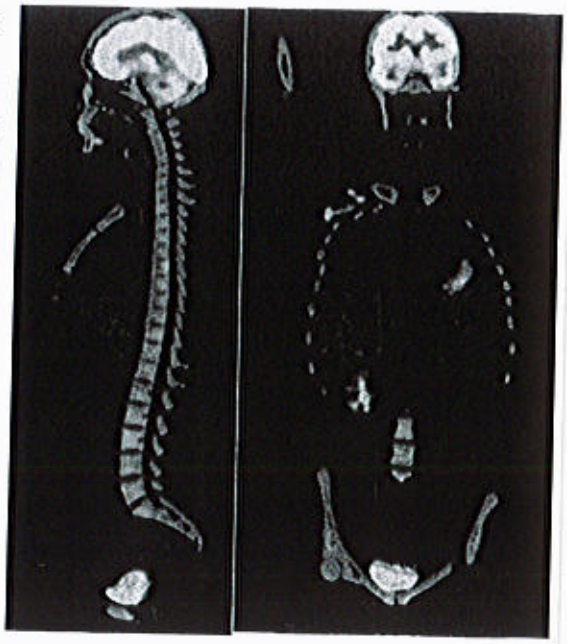
B] Chest:-

- **Enlarged metabolically active right axillary and right subpectoral lymph nodes are noted, measuring up to 21 x 30.4 mm and achieving up to 9.03 SUV max. Associated haziness and stranding of the related subcutaneous fat, likely post intervention sequelae.**
- No hypermetabolic mediastinal, hilar or left axillary lymph nodes detected. Few small non-FDG-avid left axillary lymph nodes showing preserved oval shape and central fatty hila mostly reactive in nature.
- No hypermetabolic breast soft tissue lesions detected.
- No hypermetabolic pulmonary nodules detected.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal tracer biodistribution uptake is noted in the myocardium.



C] Abdomen & Pelvis:-

- No definite sizable hypermetabolic abdominopelvic lymph nodes detected.
- **Few small non-FDG-avid left para-aortic, aortocaval, bilateral external iliac, inguinal and inguino-femoral lymph nodes are noted, measuring up to 12 mm.**
- **Evidence of previous gastric bariatric surgery with no perigastric fluid collections.**
- Post cholecystectomy metallic clips with clear operative bed.



Patient Name: هاجر محمد سعيد صابر	Study Date: 08/12/2025
PROF: عبداللطيف معوض	Patient ID: 756008

- The liver is average in size showing diffuse hypodense fatty attenuation with no hypermetabolic hepatic focal lesions detected.
- The spleen is enlarged in size with no hypermetabolic splenic focal lesions detected. Round splenule measuring 11.8 mm related to splenic visceral surface.
- There is normal distribution of the radiotracer within the gastrointestinal and genitourinary systems without focal areas of abnormal metabolism.
- Physiological uptake in adrenal glands, and pancreas.
- Physiological excretion of FDG in the kidneys.
- Right ovarian cyst measuring 45 x 50 mm with mild peripheral activity achieving up to 6.89 SUV max for sonographic correlation. Mild active small left ovarian follicle.
- No ascites.

D] Musculoskeletal:-

- No metabolically active osseous lesions could be detected along the surveyed skeleton.
- Diffuse increased bone marrow uptake mostly hyperactive bone marrow attributed to cytopenia.

CONCLUSION:-

The current PET/CT study revealed:

- **Enlarged hypermetabolic right axillary and right subpectoral lymph nodes [pathologically proven to be atypical lymphoid infiltrate] for immunophenotyping correlation.**
- **Hyperactive bone marrow.**
- **Right ovarian cyst with mild marginal activity for sonographic correlation.**
- **No other hypermetabolic nodal or extranodal lesions detected elsewhere in the body.**
- **Post therapeutic follow-up is recommended.**

MUCH OBLIGED
Dr. HANY RAAFAT.MD
PROF.DR. MAGED ABDEL-GALIL

E-Signed Dr Maged Abdelgalil

Dr.
El-Sayed Hamed Zidan
Prof . Of radio diagnosis
Color & MSK U/S
Digital X-ray
Digital mammo
Digital panorama



دكتور
السيد حامد زيدان
دكتوراه الاشعة التشخيصية
أستاذ و استشاري الأشعة التشخيصية - طب الزقازيق
دوبلر ملون للشرايين و الاوردة
تلفزيونية للأوتار و العضلات
فحص أورام الثدي و صحة المرأة
الأشعة العادية و بانوراما الأسنان الرقمية

Patiant Name : ..Miss/Hager..Mohamed.Saied Date : 20/12/2025
Dear Prof . Dr.: **National institute of cancer research and Hospital**.....

Real time ultrasonography of the right & left breast

A status post-operative with a known case of pathologically proved benign axillary lymph nodes about 5 months ago reveals

Both breast parenchyma , they display homogeneous echopattern with average , average vascularity , no focal cystic or solid lesions , no calcification , no enlarged parenchymal lymph nodes

No retroareolar masses or abnormal dilated ducts.

There are multiple ovoid hypoechoic solid lesions are seen along infra-clavicular fossa range from 32x19 mm and 30x18 mm insinuates between cords of right brachial plexus at infra-clavicular fossa and also are seen at anterior wall of right axilla , the largest measures 30x22 mm and one at lower center of axilla , all are compressible with no vascularity inside

No abnormal skin thickness or subcutaneous lesions

Normal appearance of underlying muscles.

Conclusion

Rt. axillary and infra-clavicular fossa multiple solid lesions of benignity criteria (??Enlarged lymph nodes) , however schwanommas should be considered in D.D for MRI of right brachial plexus

Thanks for referral
Dr./El-Sayed zidan
MD RADIODIAGNOSIS

العنوان: بلبيس - شارع سعد زغلول - أمام مسجد أمير الجيش
01010782848